

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO MAR 30 26 AM 9:45

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 780

INFORME POSITIVO

30 26 de marzo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto del Senado 780**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas que se incluyen en el Entrillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto del Senado 780** propone crear la "Ley para la Protección de Personas con Alergias Alimentarias en Puerto Rico", también conocida como "Ley Alejandro Benítez Ripoll"; declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre esta materia; imponer obligaciones a establecimientos de alimentos, instituciones educativas públicas y privadas y entidades postsecundarias; establecer disposiciones sobre acceso con alimentos seguros; autorizar reglamentación; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, las alergias alimentarias son una condición médica seria que impacta significativamente la vida de miles de niños, jóvenes y adultos. Para quienes viven con alergias severas, la exposición a ciertos alimentos puede provocar reacciones que van desde síntomas leves hasta anafilaxia, una emergencia médica potencialmente mortal. Esta realidad genera un riesgo constante y

limita la participación plena y segura de estas personas en espacios escolares, laborales, recreativos, sociales y comerciales.

A diferencia de otras condiciones de salud, las alergias alimentarias no son visibles. Esta invisibilidad puede llevar a actitudes de descuido, incredulidad o falta de preparación en muchos entornos, tanto públicos como privados. Para quienes viven con esta condición, cada actividad cotidiana, como asistir a clases, participar en una celebración o comer en un restaurante, puede convertirse en un momento de inseguridad, ansiedad o exclusión.



Comer fuera de casa, por ejemplo, representa una de las experiencias más limitantes, debido a la falta de protocolos claros, personal capacitado y sensibilidad hacia las instrucciones específicas que requieren estas condiciones. Los errores, aunque prevenibles, se repiten con frecuencia, y muchas veces no hay una verdadera asunción de responsabilidad. Con las herramientas adecuadas y la orientación correcta, muchas de estas situaciones podrían prevenirse. La implementación de protocolos claros representa una oportunidad real de reducir riesgos y mejorar significativamente la calidad de vida de esta población.

A pesar de lo prevenibles que pueden ser muchas de estas situaciones, no existe un marco legal local que exija estas prácticas. A pesar de los avances en el conocimiento médico y de las protecciones que ofrecen leyes federales como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Puerto Rico no cuenta con un marco legal local y específico que atienda de manera integral la realidad de las personas con alergias alimentarias severas.

La Ley ADA reconoce que estas alergias pueden considerarse una discapacidad cuando limitan funciones vitales como comer, respirar o el funcionamiento del sistema inmunológico. Por su parte, la Sección 504 prohíbe la discriminación por razón de discapacidad en programas y actividades que reciben fondos federales, incluyendo instituciones educativas, hospitales y agencias gubernamentales. Sin embargo, estas leyes, aunque importantes, no cubren todos los aspectos prácticos ni establecen medidas concretas para entornos como restaurantes, actividades recreativas o espacios comerciales.

Actualmente, no existe uniformidad en la forma en que escuelas, restaurantes y otros espacios manejan las alergias alimentarias, lo que provoca incertidumbre, frustración y

un alto nivel de riesgo para las personas afectadas. Por esta razón, Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones en Estados Unidos, necesita adoptar su propia política pública para atender esta condición de forma amplia, actualizada y adaptada a su contexto. Esta Ley responde precisamente a esa necesidad y posiciona a Puerto Rico entre las jurisdicciones que han dado pasos concretos para proteger a las personas con alergias alimentarias mediante legislación específica y acción gubernamental coordinada.

Además, atiende situaciones como desastres naturales que exponen a esta población a riesgos aún mayores, al no existir protocolos de emergencia que garanticen su protección alimentaria en refugios u operaciones de ayuda humanitaria. Asimismo, se fortalece el posicionamiento de Puerto Rico como un destino turístico accesible y seguro para visitantes de los Estados Unidos e internacionales que viven con alergias alimentarias, promoviendo entornos de hospitalidad más responsables y preparados.



Esta Ley tiene como propósito establecer una política pública afirmativa que proteja a las personas con alergias alimentarias severas, promueva su inclusión en todos los espacios y prevenga situaciones de emergencia mediante medidas educativas, preventivas y de respuesta inmediata. Se reconocen derechos fundamentales como el acceso a información clara, a protocolos de emergencia, a alimentos seguros, y a la participación plena sin barreras ni discriminación. Se establece, además, obligaciones concretas para escuelas, restaurantes, agencias gubernamentales y establecimientos comerciales en Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso de análisis y evaluación del P. del S. 780, la Honorable Comisión de Salud del Senado solicitó los comentarios sobre la medida a diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el análisis de esta pieza legislativa son: el Departamento de Salud (DS), el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Educación (DE), el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (ARV), la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), la Asociación Médica de Puerto Rico, la Asociación de Centros Comerciales de Puerto Rico (ACCP), la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEP), la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el joven Alejandro Benítez Ripoll.

Igualmente, se solicitaron los comentarios a la Asociación de Hospitales, a la Asociación de IPAS (AIPR), la Asociación Puertorriqueña de Médicos Alergistas, la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR), el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y la Oficina del Procurador del Paciente (OPP); no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.

A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias, entidades y ciudadanos consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SALUD (DS)



Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, el **Departamento de Salud (DS)**, presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Secretario, Dr. Victor M. Ramos Otero, contando con el insumo de la División de Salud Ambiental adscrita a la Secretaría Auxiliar para la Vigilancia y Protección de la Salud Pública, así como de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (en adelante CANPR), expresándose en contra de la aprobación de la medida. No obstante, reconoció el interés público legítimo que inspira la propuesta legislativa y la importancia de atender las alergias alimentarias como un asunto serio de salud pública que incide directamente en la seguridad y calidad de vida de la población.

El Departamento sostuvo que la materia objeto de la medida ya se encuentra regulada dentro del marco normativo vigente. Destacó, que desde el año 2000, Puerto Rico adoptó por referencia el *Federal Food Code* de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA), el cual incluye disposiciones detalladas sobre el manejo de alérgenos, etiquetado, inspección y supervisión de establecimientos de alimentos. En consecuencia, argumentó que la política pública nacional en torno a la presencia de alérgenos ya ha sido implementada en la jurisdicción.

Asimismo, el Departamento enfatizó que la regulación de aspectos relacionados con la calidad, manejo, almacenamiento y preparación de alimentos constituye una función inherente y exclusiva de salud pública, adscrita a su deber ministerial. El Departamento advirtió que la asignación de competencias técnicas a otras agencias podría generar

conflictos regulatorios y diluir la autoridad primaria del Departamento en materia sanitaria.

De igual forma, puntualizó que, de aprobarse la medida, sería indispensable fortalecer la División de Salud Ambiental mediante la creación de catorce (14) plazas adicionales de inspectores, lo que representaría un impacto presupuestario estimado en quinientos cuarenta y tres mil seiscientos dólares (\$543,600) anuales. En consecuencia, recomendó que cualquier legislación contemple asignaciones recurrentes que garanticen su implementación efectiva. Además, sugirió la imposición de multas administrativas de doscientos dólares (\$200) por infracción, cuyos recaudos se destinarían a sufragar los costos operacionales de fiscalización, asegurando además el debido proceso administrativo para su revisión.



En el plano técnico-médico, el memorial desarrolló una exposición detallada sobre la naturaleza de las alergias alimentarias, distinguiendo entre reacciones mediadas por inmunoglobulina E (IgE) y aquellas no mediadas, resaltando la importancia de la epinefrina autoinyectable como tratamiento de primera línea en casos de anafilaxia. Sin embargo, insistió en que estas consideraciones clínicas ya forman parte del andamiaje regulatorio y educativo vigente bajo la normativa federal y estatal adoptada.

En síntesis, aunque el Departamento de Salud expuso que la creación de una nueva ley específica podrá resultar redundante y potencialmente conflictiva con el marco regulatorio existente. Por tal razón, fundamentado en consideraciones de competencia técnica, coherencia normativa y viabilidad fiscal, la agencia no endosó la aprobación del Proyecto del Senado 780 en su forma actual.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (DACO)

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), al amparo de su Ley Orgánica, compareció ante la Comisión de Salud, por conducto de su Secretario, Lcdo. Hiram J. Torres Montalvo, para expresar su postura respecto al Proyecto del Senado 780, el cual propone la creación de la "Ley para la Protección de Personas con Alergias Alimentarias en Puerto Rico". La agencia reconoció como loable la intención legislativa de fortalecer la protección de los consumidores, particularmente de aquellas personas que padecen alergias alimentarias severas, promoviendo su inclusión y seguridad en los establecimientos donde se preparan y expenden alimentos.

El DACO afirmó que la medida se alinea con su deber ministerial de vindicar y proteger los derechos de los consumidores puertorriqueños. Asimismo, sostuvo que el proyecto persigue establecer mecanismos preventivos y de respuesta inmediata que reduzcan riesgos y promuevan un entorno más seguro para esta población vulnerable.

No obstante, tras analizar la pieza legislativa, puntualizó que la Agencia con la pericia técnica primaria en la materia es el Departamento de Salud, en conjunto con el Departamento de Educación, por tratarse de asuntos inherentes a la salud pública y a la administración de protocolos escolares. En consecuencia, recomendó que se consulte formalmente a dichas agencias para asegurar coherencia reglamentaria y uniformidad en la implementación de la política pública propuesta.



De igual forma, el DACO sugirió que la medida incorpore un periodo de transición más amplio, con el propósito de permitir el desarrollo de reglamentos adecuados, la capacitación del personal, y la orientación tanto a comerciantes como a consumidores sobre los derechos y obligaciones que surgirían bajo la nueva ley. Este planteamiento responde a una visión de implementación ordenada y responsable, evitando cargas abruptas o desarticuladas.

Por otra parte, la Agencia manifestó su disposición a colaborar activamente en campañas educativas y en la fiscalización del cumplimiento, particularmente a través de su personal inspector. Además, destacó que ya cuenta con el Reglamento Núm. 9158 de 6 de febrero de 2020, conocido como "Reglamento de Prácticas Comerciales", el cual contiene disposiciones dirigidas a fiscalizar prácticas y anuncios engañosos, así como la divulgación de datos nutricionales en establecimientos de comida rápida, herramientas que podrían complementar la política pública propuesta.

En síntesis, el Departamento de Asuntos del Consumidor favoreció la aprobación del Proyecto del Senado 780, sujeto a la adecuada coordinación interagencial y a una implementación estructurada que garantice la efectividad de la medida. Su postura refleja un respaldo condicionado y colaborativo, orientado a proteger los derechos del consumidor sin menoscabar las competencias técnicas primarias de las agencias de salud pública.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (DE)

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por el **Departamento de Educación (DE)** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Secretario, Lcdo. Eliezer Ramos Parés, expresándose a favor de la aprobación de la medida.

El Departamento enmarcó su intervención dentro de su deber constitucional de garantizar una educación pública integral, segura e inclusiva, conforme al Artículo II, Sección 5 de la Constitución de Puerto Rico y a la Ley 85-2018, conocida como "Ley de Reforma Educativa". En ese sentido, reconoció que la protección de estudiantes con alergias alimentarias severas no constituye meramente un asunto operacional, sino una dimensión directa del derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad y seguridad.



En el plano sustantivo, sostuvo que la medida persigue un fin legítimo y apremiante, a saber, establecer un marco normativo uniforme que atienda de manera integral la realidad de estudiantes que enfrentan alergias alimentarias potencialmente mortales. A tales efectos, destacó que la ausencia de legislación local específica puede generar disparidades en la aplicación de protocolos y en la disponibilidad de mecanismos preventivos y de respuesta inmediata en los planteles escolares.

No obstante, la agencia argumentó que, en la práctica administrativa vigente, ya existen instrumentos regulatorios y operacionales que atienden esta problemática. Particularmente, resaltó la implementación de los Programas de Nutrición del Niño y la adopción de formularios médicos oficiales como el "Informe Médico Dietas Especiales y/o Acomodo Razonable" que permiten documentar y ejecutar acomodos razonables para estudiantes con condiciones alimentarias específicas. Asimismo, hizo referencia a directrices recientes que aceptan certificaciones de profesionales cualificados, como dietistas registrados, para viabilizar modificaciones alimentarias conforme a criterios clínicos reconocidos.

En esa misma línea, el Departamento subrayó que las alergias y las intolerancias alimentarias son atendidas en la confección de menús especiales, lo que evidencia que el sistema educativo ya opera bajo un esquema de razonabilidad y prevención. Sin embargo, recomendó que el texto legislativo incorpore expresamente el término

"intolerancia alimentaria", a fin de evitar interpretaciones restrictivas y asegurar coherencia conceptual con la práctica administrativa existente.

Por otra parte, al examinar los artículos que inciden directamente sobre su operación, en particular aquellos relativos a protocolos escolares, disponibilidad de epinefrina autoinyectable y sistemas de reporte, el Departamento manifestó su respaldo sustantivo a la intención de fortalecer la uniformidad institucional. Argumentó, que la estandarización normativa contribuiría a reducir riesgos, mejorar la capacitación del personal y establecer métricas claras de cumplimiento.



La Agencia advirtió que cualquier mecanismo obligatorio de recopilación o divulgación de información deberá armonizarse estrictamente con las leyes federales y estatales de confidencialidad, incluyendo la Ley HIPAA y la normativa federal de derechos civiles, especialmente cuando se trate de información médica de menores de edad. De esta manera, enfatizó la necesidad de balancear la transparencia y la rendición de cuentas con la protección de datos sensibles.

En conclusión, el Departamento de Educación expresó su respaldo a la aprobación del Proyecto del Senado 780, entendiendo que la medida no solo complementa los protocolos vigentes, sino que robustece la política pública educativa en materia de inclusión y seguridad alimentaria. A su juicio, la aprobación de la medida consolidaría una estructura normativa más uniforme, fortalecería la coordinación interagencial y reafirmaría el compromiso del Estado con la protección integral de la niñez en el entorno escolar.

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES (DRD)

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por el **Departamento de Recreación y Deportes (DRD)** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Secretario, Héctor Vázquez Muñiz, expresándose en a favor de la aprobación de la medida sujeto a la incorporación de enmiendas.

La Agencia reconoció la seriedad de las alergias alimentarias como una condición médica que impacta significativamente la vida de niños, jóvenes y adultos, particularmente en contextos donde se desarrollan actividades físicas y recreativas. Desde esa perspectiva, el DRD asumió una postura responsable y proactiva, al entender que el ejercicio físico

puede intensificar las respuestas alérgicas, lo que convierte este asunto en uno de especial pertinencia dentro del ámbito deportivo.

El Departamento coincidió con la Exposición de Motivos del proyecto al reconocer que las alergias alimentarias constituyen un asunto de salud pública que requiere atención estructurada. Por consiguiente, el DRD sostuvo que la aprobación de la medida representa un paso afirmativo hacia la protección de la vida y seguridad de las personas que participan en actividades recreativas y deportivas. En ese sentido, el DRD destacó la importancia de integrar esfuerzos interagenciales, particularmente con el Departamento de Salud, para asegurar que la implementación de la política pública esté respaldada por criterios científicos adecuados.



Asimismo, enfatizó la relevancia de desarrollar campañas educativas dirigidas a aumentar la concienciación sobre alergias alimentarias, prevenir exposiciones accidentales y promover respuestas adecuadas ante emergencias. De manera específica, el DRD planteó incorporar capacitación sobre el manejo seguro de alimentos y protocolos de respuesta en los cursos que se ofrecen a líderes recreativos, entrenadores, instructores y asociaciones deportivas a través del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación. Asimismo, subrayó que la medida persigue fortalecer las competencias del personal y garantizar entornos recreativos más seguros e inclusivos.

De igual forma, el Departamento favoreció la aplicación de medidas preventivas en centros recreativos, deportivos y campamentos, en armonía con lo dispuesto para restaurantes y otros establecimientos de alimentos. No obstante, el DRD sugirió considerar ciertas exenciones para quioscos o cantinas operadas por voluntarios o padres, siempre que tales excepciones no comprometan la salud, seguridad ni los derechos de las personas con alergias alimentarias. Además, respaldó la colocación de letreros visibles que informen sobre alérgenos comunes, promoviendo decisiones informadas por parte de los consumidores.

El DRD endosó la autorización para el ingreso y uso de epinefrina autoinyectable por personas autorizadas, así como el acceso a alimentos personales seguros en instalaciones recreativas o deportivas. Sin embargo, advirtió que dicha disposición podría generar resistencia en ciertos establecimientos que restringen la entrada de alimentos externos, por lo que sugirió evaluar mecanismos que permitan corroborar que la excepción responde a una necesidad médica legítima. Igualmente, recomendó definir con mayor

precisión el concepto de "área libre de alérgenos", a fin de evitar ambigüedades en la interpretación e implementación de la ley.

En síntesis, el Departamento de Recreación y Deportes respaldó el Proyecto del Senado 780, sujeto a las recomendaciones planteadas y con deferencia a la evaluación técnica del Departamento de Salud. Así, el memorial refleja una postura de apoyo responsable, orientada a armonizar la protección de la salud pública con la realidad operacional de los entornos recreativos y deportivos en Puerto Rico.

DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMIENTOS (DPI)



El Memorial Explicativo presentado por la **Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI)**, por conducto de su Abogado Principal, Lcdo. José A. Montalvo Vera, analiza el Proyecto del Senado 780 desde una perspectiva jurídica y de derechos civiles, endosando la medida con recomendaciones específicas dirigidas a fortalecer su viabilidad y efectividad. La Defensoría coincidió con la exposición de motivos del proyecto, particularmente en cuanto a la necesidad de establecer una política pública afirmativa que garantice la protección, inclusión y seguridad de las personas con alergias alimentarias severas.

El DPI reconoció que las alergias alimentarias severas pueden constituir impedimentos bajo la legislación federal aplicable, específicamente la *Americans with Disabilities Act (ADA)* y el *Rehabilitation Act de 1973*, en la medida en que dichas condiciones pueden limitar sustancialmente funciones corporales principales, tales como el sistema respiratorio y digestivo. Por consiguiente, sostuvo, que el proyecto no solo atiende un asunto de salud pública, sino también una dimensión de derechos civiles y no discrimen, lo que robustece su fundamento jurídico.

Asimismo, la entidad enfatizó la necesidad de integrar al Departamento de Salud en la discusión legislativa, dado que el mecanismo, severidad y manejo de las alergias alimentarias constituyen materias eminentemente médicas; de esta manera, asegurando que la implementación de la política pública esté sustentada en criterios científicos y clínicos adecuados.

De igual forma, señaló que el memorial hace referencia al acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia Federal y Lesley University en Massachusetts, el cual requirió ajustes razonables en la provisión de servicios de alimentos para estudiantes con alergias

severas. Añadió, que este precedente demuestra que las instituciones educativas y los proveedores de alimentos pueden estar sujetos a obligaciones específicas bajo la normativa de derechos civiles.

Además, puntualizó que, aunque el *Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act* (FALCPA) regula alimentos pre-empacados, no cubre restaurantes; sin embargo, diversos estados han adoptado legislación que sí impone obligaciones a establecimientos de servicio de alimentos. El DPI sugirió que en Puerto Rico se puede diseñar un modelo similar que contemple adiestramiento obligatorio, rotulación visible y divulgación de información educativa.



Por otra parte, formuló recomendaciones relacionadas con la exigencia de epinefrina autoinyectable en restaurantes y escuelas. En ese sentido, propuso evaluar incentivos contributivos o mecanismos de acceso gubernamental al medicamento para mitigar el impacto económico sobre los comerciantes. A su vez, advirtió sobre la necesidad de revisar cuidadosamente el lenguaje del proyecto en cuanto a la autoadministración del medicamento por menores de edad, dado que su uso incorrecto puede generar complicaciones médicas severas.

Finalmente, la Defensoría planteó la conveniencia de incluir disposiciones claras sobre relevo de responsabilidad para los dueños de establecimientos que, en una emergencia, faciliten el acceso al medicamento, considerando que las disposiciones vigentes sobre el "buen samaritano" podrían no cubrir plenamente estas intervenciones. En síntesis, el memorial concluye que el Proyecto del Senado 780 representa una medida que promueve el apoderamiento y mejora la calidad de vida de las personas con alergias severas. No obstante, recomendó ajustes específicos para armonizar la protección de derechos, la responsabilidad legal y la viabilidad práctica de su implementación.

ADMINISTRACIÓN DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS (ARV)

La Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (ARV) presentó su Memorial Explicativo en torno a la medida mostrándose a favor de su aprobación, por conducto de su Administradora, Dra. Rosa H. Lugo Cabán.

La ARV contextualizó su base legal bajo la Ley Pública Federal 93-112 de 1973, según enmendada, conocida como la Ley de Rehabilitación, así como el *Workforce Innovation and Opportunity Act* (WIOA), destacando su misión de integrar a las personas con impedimentos a la fuerza laboral y promover su independencia. Desde esa óptica, la agencia subrayó que la incapacidad no disminuye el derecho a la autodeterminación, inclusión y participación plena en la sociedad, principio que armoniza directamente con la intención protectora del Proyecto del Senado 780.



Asimismo, la ARV reconoció que las alergias alimentarias severas constituyen una preocupación creciente de salud pública. A tales efectos, la Agencia citó datos del CDC que evidencian la prevalencia significativa de esta condición, particularmente en menores de edad, así como su potencial gravedad en casos de anafilaxia. En consecuencia, validó la pertinencia de establecer protocolos claros de prevención y respuesta, especialmente en entornos donde se congregan poblaciones vulnerables. Además, destacó literatura científica que vincula una mayor prevalencia de alergias alimentarias en poblaciones con Trastorno del Espectro Autista, lo que refuerza la necesidad de un enfoque inclusivo y sensible a la diversidad funcional.

De igual forma, la ARV realizó un análisis jurídico del alcance del *Americans with Disabilities Act* (ADA), la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y el *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA), y puntualizó que las alergias alimentarias severas pueden constituir una discapacidad cuando limitan funciones vitales. No obstante, señaló que no todas las personas con alergias alimentarias necesariamente cumplen con los criterios de elegibilidad bajo IDEA o la Sección 504, aunque ello no exime a las instituciones de implementar medidas razonables de protección. En este contexto, la ARV sugirió que la legislación considere integrar con mayor precisión los mecanismos existentes, como el Programa Educativo Individualizado (PEI) o el Plan de Servicios bajo la Sección 504, para documentar protocolos específicos de manejo.

La ARV endosó la necesidad de uniformidad en el manejo de alergias alimentarias en escuelas, restaurantes y espacios públicos, al coincidir con la exposición de motivos del proyecto en que la ausencia de estándares claros incrementa el riesgo para esta población. En cuanto a las obligaciones propuestas para establecimientos de alimentos, respaldó la exigencia de identificar alérgenos en los menús, aunque recomienda incluir clasificaciones específicas como "*Gluten Free (GF)*" y acompañar la medida con campañas educativas dirigidas tanto a la ciudadanía como al personal de los establecimientos.

En relación con las instituciones educativas, la ARV avaló la adopción de protocolos escritos y la capacitación anual del personal; sin embargo, formuló observaciones técnicas sobre la injerencia del Departamento de Educación en instituciones postsecundarias, sugiriendo que la responsabilidad principal recaiga en el Departamento de Salud. Asimismo, subrayó la atención sobre las disposiciones relacionadas con el almacenamiento de epinefrina autoinyectable, recomendando considerar el marco regulatorio vigente bajo la Ley de Farmacia de Puerto Rico respecto a licencias de botiquín. Igualmente, enfatizó que los protocolos de autoadministración deben ajustarse a la edad, madurez y condición funcional del estudiante, particularmente en casos de impedimentos significativos.



En lo que respecta al derecho de acceso con alimentos personales seguros en espacios públicos y privados, la ARV expresó que no observa inconveniente alguno desde el punto de vista de cumplimiento, al entender que la salud debe prevalecer sobre restricciones comerciales. De hecho, señaló que en sus propias instalaciones ya se permite esta práctica, incluyendo almacenamiento y refrigeración cuando es necesario.

En síntesis, la ARV concluyó que, aunque la medida no está directamente vinculada a su función primaria como agencia de integración laboral, la intención legislativa es loable y beneficiosa para la población con alergias alimentarias severas. En síntesis, el memorial combina respaldo institucional con recomendaciones técnicas específicas, orientadas a armonizar la política pública propuesta con el marco jurídico vigente y las realidades operacionales de las agencias gubernamentales, promoviendo así una implementación efectiva y coherente.

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO (CTPR)

La **Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)** presentó su Memorial Explicativo en torno a la medida mostrándose a favor de su aprobación, por conducto de su Directora Ejecutiva, Willianette Robles Cancel. Desde la perspectiva del desarrollo turístico y la competitividad del destino, reconoció el mérito sustantivo de la medida y su potencial impacto positivo sobre la imagen y reputación de Puerto Rico como destino seguro e inclusivo.

La CTPR sostuvo que la política pública propuesta atiende una realidad que incide directamente en la experiencia del visitante: la protección de personas con alergias

alimentarias severas. En consecuencia, destacó que la previsibilidad en los servicios, la reducción de riesgos y la existencia de protocolos claros son factores determinantes en la selección de destinos turísticos. Mencionó que, en un mercado altamente competitivo, donde los visitantes valoran la seguridad y la preparación ante condiciones médicas potencialmente graves, la adopción de medidas preventivas puede fortalecer la confianza del turista y proteger la reputación del destino.

Asimismo, la CTPR subrayó que la industria turística enfrenta una demanda creciente por entornos accesibles y preparados para atender condiciones de salud que, aunque no siempre visibles, pueden tener consecuencias graves. Desde esta óptica, puntualizó, que la medida contribuiría a proyectar a Puerto Rico como un destino alineado con los estándares prevalecientes en el mercado de los Estados Unidos y otros mercados internacionales, consolidando su posicionamiento dentro del Caribe como un destino responsable y competitivo.

No obstante, aclaró que su rol en la implementación de la política pública no sería primario ni ejecutor; por el contrario, su participación se circunscribe a la colaboración institucional, orientación estratégica y coordinación interagencial dentro de los límites de su mandato estatutario. En ese sentido, enfatizó que las consideraciones técnicas, sanitarias y regulatorias recaen principalmente en el Departamento de Salud y en el Departamento de Asuntos del Consumidor, entidades con la pericia especializada y autoridad legal para reglamentar y fiscalizar las obligaciones propuestas.

De igual forma, la CTPR destacó su historial de colaboración interagencial en iniciativas que impactan la actividad turística, particularmente en campañas de orientación al visitante y coordinación en materia de seguridad. Sin embargo, la agencia recalcó que dicha colaboración se ha dado siempre dentro de los contornos de su competencia legal, sin asumir funciones técnicas que correspondan a otras agencias. Por consiguiente, recomendó auscultar la postura del Departamento de Salud, a fin de contar con una evaluación técnica completa sobre la viabilidad operativa y los mecanismos de cumplimiento que la medida implicaría.

En síntesis, la Compañía de Turismo destacó que, desde la óptica turística, el Proyecto del Senado 780 fortalece la imagen de Puerto Rico como destino seguro, inclusivo y responsable, reduciendo riesgos reputacionales para hoteles, restaurantes y operadores

turísticos. No obstante, condicionó su respaldo a la evaluación técnica correspondiente por parte de las agencias con competencia primaria.

ASOCIACIÓN MÉDICA DE PUERTO RICO

La **Asociación Médica de Puerto Rico** presentó su Memorial Explicativo en torno a la medida, por conducto de su Presidente, Edgardo N. Rosario Burgos, mostrándose en contra de su aprobación.

Manifestó, que la propuesta atiende un problema real y coloca sobre la mesa la necesidad de uniformar prácticas, fortaleciendo la prevención y promoviendo ambientes más seguros para esta población. Sin embargo, indicó que, tras analizar el proyecto con responsabilidad técnica y administrativa, entendió necesario llamar la atención de esta Honorable Comisión sobre consideraciones esenciales que aún no han sido definidas y que resultan indispensables antes de avanzar con una legislación de este alcance.



Coincidió con la intención legislativa de promover mayor concienciación sobre las alergias alimentarias, fortalecer protocolos preventivos y reducir riesgos en entornos escolares, comerciales y recreativos. Asimismo, reconoció la urgencia de uniformar prácticas y evitar errores que pueden resultar fatales, lo cual es cónsono con principios fundamentales de salud pública. No obstante, aclaró que respaldar la intención no implica necesariamente que el proyecto, en su redacción actual, sea ejecutable sin ajustes sustanciales.

En ese sentido, la entidad médica identificó varias limitaciones estructurales que a su juicio deben atenderse antes de la aprobación de la medida. En particular, destacó la ausencia de un análisis detallado del impacto fiscal. Señaló, que la implementación del proyecto implicaría costos asociados a adiestramientos recurrentes, adquisición y reposición de epinefrina autoinyectable, creación de sistemas de reporte, fiscalización continua, contratación o asignación de personal adicional, desarrollo de campañas educativas y coordinación interagencial. Fundamentó, que ninguno de estos componentes aparece cuantificado o acompañado de un desglose presupuestario de la medida.

Enfatizó en la falta de identificación clara de los recursos humanos, tecnológicos y operacionales necesarios para la ejecución efectiva de la medida. En el contexto de la situación fiscal actual del Gobierno y la fragilidad económica de múltiples sectores

privados, advirtió que muchas agencias y establecimientos podrían carecer de la capacidad para asumir las obligaciones impuestas. Por consiguiente, mencionó que aprobar la legislación sin este análisis previo podría generar incumplimientos involuntarios y cargas administrativas desproporcionadas.

De igual forma, la Asociación Médica planteó preocupaciones en torno a la supervisión y fiscalización. Específicamente, señaló que el proyecto no define con precisión quién supervisará cada obligación, cuáles serán los mecanismos de auditoría, la frecuencia de inspecciones ni los criterios de cumplimiento. Esbozó que la legislación propuesta no detalla los procesos claros para la validación de querellas, lo que podría abrir la puerta a reclamaciones infundadas y exposición legal innecesaria tanto para el sector público como privado.



Por otra parte, alegó que, aunque el proyecto menciona fases de implementación, no estableció un plan escalonado con plazos definidos, criterios operacionales mínimos ni asignaciones presupuestarias específicas que requiere un diseño estructurado que garantice sostenibilidad y ejecutabilidad.

En síntesis, la Asociación Médica de Puerto Rico expresó el valor y la intención protectora del Proyecto del Senado 780; sin embargo, por razones de responsabilidad fiscal, administrativa y de salud pública, no endosó su aprobación en su forma actual. En consecuencia, exhortó a la Comisión a realizar un análisis formal del impacto fiscal, la disponibilidad de recursos y la capacidad real de cumplimiento antes de avanzar con la medida. Añadió que, solo mediante datos objetivos y planificación estructurada podrá diseñarse un marco normativo responsable, sostenible y ajustado a la realidad operacional de Puerto Rico.

ASOCIACIÓN DE CENTROS COMERCIALES PUERTORRIQUEÑOS

La Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños presentó su Memorial Explicativo en torno a la medida, por conducto de su Presidenta, la Sra. Marnie Marquin, mostrándose en contra de su aprobación. Expresó que, si bien favorecía iniciativas dirigidas a proteger al consumidor y a promover empatía hacia sectores con necesidades especiales, el proyecto no utiliza el mecanismo adecuado para alcanzar dichos fines.

Sostuvo, que la medida forma parte de una tendencia legislativa que, a su juicio, había transferido funciones inherentes de fiscalización y regulación gubernamental al sector

privado. En consecuencia, argumentó que imponer tales responsabilidades a las empresas privadas implica una carga adicional que corresponde originalmente al Estado. Asimismo, señaló que las empresas ya contribuyen al erario precisamente para que el gobierno ejerza dichas funciones, por lo que asumirlas nuevamente representaría un doble costo y una duplicidad de responsabilidades.

La Asociación planteó que el ciudadano, junto con su núcleo familiar, tiene una responsabilidad inherente de educarse y velar por su salud al momento de consumir alimentos. Por consiguiente, es de la opinión que dicha responsabilidad individual no debe trasladarse completamente al comerciante o administrador de establecimientos privados. Además, advirtió, que el proyecto generaría un andamiaje operacional costoso, incluyendo requisitos de capacitación especializada, protocolos obligatorios, rotulación específica y otras medidas que incrementarían la carga burocrática y regulatoria ya existente en Puerto Rico.

La Asociación destacó, que el sector privado enfrenta múltiples exigencias gubernamentales, por lo que añadir nuevas obligaciones sin un análisis integral del impacto económico resultaría oneroso y desproporcionado. En consecuencia, exhortó a la Comisión a considerar alternativas menos gravosas que permitieran atender los objetivos legítimos de la legislación sin imponer mayores cargas al comercio.

En síntesis, la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños se opuso a la aprobación del Proyecto del Senado 780 en su forma propuesta, al entender que la medida traslada funciones estatales al sector privado y genera costos adicionales significativos. No obstante, dejó abierta la posibilidad de ampliar o suplementar sus comentarios y reiteró su disposición a colaborar con la Comisión en la evaluación de legislación que impactara a sus miembros.

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA DE PUERTO RICO

La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico presentó su Memorial Explicativo en contra de la aprobación de la medida por conducto de su Presidenta, Emma Sulsona Gándara y su Directora Ejecutiva, Wanda Ayala de Torres.

Sustentó, que la implementación propuesta resulta excesivamente onerosa y contraria al marco jurídico vigente, particularmente a la Ley 212-2018. Puntualizó su posición destacando su rol histórico como representante del sector privado educativo en Puerto

Rico y subrayó que la Ley 212-2018 consagra una política pública de respeto a la autonomía institucional. Añadió, que dicha Ley reconoce expresamente el ámbito de libertad académica y administrativa de las instituciones privadas, protegiéndolas de interferencias gubernamentales que menoscaben su misión, valores y filosofía curricular. Por consiguiente, alertó que, cualquier legislación que imponga obligaciones uniformes sin considerar esa autonomía podría, vulnerar el ordenamiento jurídico vigente.



Asimismo, la Asociación de Educación Privada planteó que las alergias alimentarias constituyen una condición médica seria, potencialmente mortal y que requiere atención adecuada. No obstante, argumentó que, en el contexto de las instituciones privadas, la responsabilidad primaria de comunicar y manejar esta condición recae en las familias. La entidad explicó que el proceso de matrícula incluye la entrega de certificaciones médicas oficiales, las cuales son archivadas y comunicadas internamente al personal pertinente. Señaló, que este modelo, basado en la coordinación entre familia e institución, ha funcionado históricamente de manera efectiva. En consecuencia, sostuvo que la participación de los padres es indispensable y que ninguna medida institucional puede sustituir dicha responsabilidad compartida.

Por otra parte, la Asociación de Educación Privada planteó que el proyecto impone una serie de obligaciones que resultan desproporcionadas para las instituciones privadas. Entre estas, destacó la exigencia de protocolos escritos aprobados por los Departamentos de Salud y Educación y señaló que el Departamento de Educación carece de jurisdicción sobre instituciones privadas. Asimismo, objetó la obligación de mantener epinefrina autoinyectable accesible, considerando que el manejo de medicamentos debe realizarse exclusivamente bajo supervisión de personal de enfermería, cuya contratación no es obligatoria en el sector privado.

De igual forma, cuestionó la imposición de capacitación anual obligatoria a todo el personal en materia de alergias alimentarias, uso de epinefrina y primeros auxilios, argumentando que ello podría exponer a empleados no especializados a responsabilidades médicas para las cuales no están preparados. Además, señaló, que la elaboración, revisión y actualización anual de planes individualizados para cada estudiante con alergias representa una carga significativa en términos de recursos humanos, tiempo y costos operacionales, particularmente para instituciones con estructuras administrativas limitadas.

En lo que respecta al requisito de notificación de incidentes al Departamento de Salud en un plazo específico, advirtió que muchas instituciones privadas no cuentan con personal administrativo suficiente para cumplir con este tipo de obligaciones adicionales, lo que incrementaría la carga burocrática y operativa.

En síntesis, la Asociación de Educación Privada concluyó que, aunque la medida persigue un propósito legítimo y necesario, su aplicación a las instituciones educativas privadas interfiere con la autonomía protegida por la Ley 212-2018 y excede las capacidades reales del sector. Por tanto, sostuvo que el Proyecto del Senado 780, en su redacción actual, carece de jurisdicción para imponer tales obligaciones al sector privado educativo. No obstante, reafirmó la importancia de la colaboración entre escuelas y familias en el manejo responsable de las alergias alimentarias, promoviendo un enfoque de corresponsabilidad que no sustituya las obligaciones inherentes a cada parte.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (UPR)

La Universidad de Puerto Rico (UPR), luego de consultar con la Escuela de Profesiones de la Salud (EPS) y con la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), presentó su Memorial Explicativo en torno a la medida mostrándose a favor de su aprobación, por conducto de su Presidenta, Dra. Zayira Jordán Conde.

La UPR contextualizó el problema desde una perspectiva de salud pública, señalando que las alergias alimentarias constituyen una condición prevalente y en aumento a nivel global, particularmente en países desarrollados. Asimismo, documentó que en Estados Unidos la incidencia se ha duplicado en las últimas décadas, afectando a un porcentaje considerable de niños y adultos. Por consiguiente, enfatizó que las alergias alimentarias deben atenderse como un problema estructural que requiere una respuesta legislativa integral.

La entidad educativa subrayó que, en Puerto Rico no existen estadísticas oficiales sistematizadas ni un marco legal específico que regule de forma coherente la prevención, manejo y respuesta ante alergias alimentarias en espacios escolares, restaurantes y establecimientos comerciales. Señaló, que esta carencia normativa, según se argumenta, coloca a las familias en un estado de desprotección jurídica y sanitaria, generando inseguridad y exclusión. En consecuencia, la medida propuesta se presenta como un instrumento indispensable para garantizar seguridad, inclusión y acceso equitativo.

De igual manera, la UPR planteó que el Proyecto del Senado 780 reconoce derechos fundamentales como el acceso a información clara, alimentos seguros y protocolos de emergencia, al tiempo que impone obligaciones concretas a establecimientos de alimentos, instituciones educativas y entidades gubernamentales. En ese sentido, promueve la capacitación del personal, la adopción de estándares claros de manejo de alérgenos, el etiquetado adecuado y la coordinación interagencial. La UPR indicó que, así se configura una política pública preventiva, educativa y correctiva alineada con modelos regulatorios vigentes en otras jurisdicciones.

Añadió, que la medida detalla beneficios concretos tales como la protección efectiva del consumidor mediante etiquetado claro, la educación y concienciación pública, la responsabilidad de los establecimientos para evitar contaminación cruzada, y la creación de estándares uniformes para la preparación y manejo de alimentos. Aludió que estas disposiciones, no solo reducen el riesgo de reacciones severas, sino que fortalecen la confianza del consumidor y elevan los parámetros de salud pública.

Finalmente, la Universidad formuló recomendaciones generales y específicas para robustecer la medida:

1. Seguir las guías de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), para orientar a la comunidad cómo evitar alergias alimentarias.
2. Crear conciencia de las alergias alimentarias y asuntos relacionados tales como: alérgenos comunes, síntomas, contaminación cruzada.
3. Capacitar en los siguientes escenarios: industria alimentaria (restaurantes y establecimientos de alimentos); entornos escolares; lugares recreativos (campamentos, lugares turísticos) y lugares de cuidado médico.
4. Incluir en este Proyecto un representante especialista en Nutrición y Dietética licenciado en Puerto Rico para desarrollar un plan educativo en nutrición sobre posibles alérgenos en listados de ingredientes de la etiqueta nutricional, alimentos que pueden causar alergias y métodos de preparación de alimentos donde incluyen alérgenos.
5. Solicitar que se requiera a los comerciantes locales relacionados a la producción y venta de alimentos preparados en Puerto Rico, que coloquen en su etiqueta un aviso de posibles alérgenos tanto en el alimento, en los ingredientes o posible contaminación con alérgenos.

- 
6. Solicitar a toda empresa privada o pública que sirva alimentos tipo bufete, que debe colocar un aviso frente al alimentos de la posibilidad de tener componentes alergénicos. Debe indicar que tipo de alimento o preparación está incluido en ese aviso.
 7. Permitir a los pacientes en edad escolar portar su epinefrina auto-inyectable y medicamentos orales para tratar reacciones alérgicas. La epinefrina inyectable debe ser accesible y rápida a los pacientes con alergias alimentarias. Para esto será necesario la cubierta del medicamento a aquellos pacientes con historial médico de alergias alimentarias y no exclusivamente a aquellos que hayan experimentado reacción severa. En pacientes menores de edad que no tengan la destreza para aplicarse el medicamento, que estos sean administrados por la enfermera escolar y/o personal identificado debidamente capacitado. Se sugiere utilizar una guía uniforme (similar al utilizado por el Departamento de Salud para pacientes con asma) donde por medio de una orden médica y un documento estandarizado, se autorice al paciente o a la enfermera escolar a administrar los medicamentos. Además, el documento incluiría el protocolo a seguir en caso de una reacción alérgica a alimento, la cual puede ir de leve a severa. Esto debe ser certificado por el pediatra, médico primario o alergista.
 8. Establecer mecanismos legales para asegurar que cualquier establecimiento de servicio de alimentos cumple con la regulación de indicar la presencia de alérgenos, cual alérgeno y en que alimento se puede encontrar.
 9. Establecer un programa de vigilancia de que las empresas de servicios de alimentos cumplan con cursos de educación continua en el tema de alergias alimentarias.
 10. Invitar a las universidades del país con programas de nutrición, ciencia de alimentos, y tecnología de alimentos a ser parte de este Comité, para desarrollar proyectos de investigación que estudien los efectos de estos proyectos en las comunidades, además de proyectos de intervención comunitarias y de educación en nutrición y prevención de alergias alimentarias.
 11. Crear un perfil de alergias alimentaria en Puerto Rico con el fin de desarrollar programas para reducir alergias alimentarias Puerto Rico, mencionados en el memorial.
 12. Adoptar protocolos en preparación y respuesta en situaciones de emergencia en los distintitos entornos y escenarios anteriormente mencionados en el memorial.
 13. Documentar las estadísticas de pacientes con alergias alimentarias y definir los criterios a ser incluidos como parte de éstas.

ALEJANDRO MIGUEL BENÍTEZ RIPOLL

El Memorial Explicativo presentado por **Alejandro Miguel Benítez Ripoll** ante la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico constituye un testimonio directo y profundamente fundamentado en la experiencia vivida de una persona que convive con alergias alimentarias severas. El joven expresó su apoyo total al Proyecto del Senado 780 y destacó que la medida surge precisamente como resultado de su vivencia cotidiana y de la necesidad real de atender un vacío normativo en la protección de esta población.

Benitez Ripoll contextualizó la realidad de vivir con alergias alimentarias severas como una condición médica seria, potencialmente mortal y permanente, que impone un estado constante de vigilancia y planificación. Añadió, que las actividades que para la mayoría de la población en Puerto Rico resultan espontáneas, como asistir a una actividad escolar, visitar un restaurante o participar en eventos deportivos, requieren anticipación rigurosa, coordinación y evaluación constante del riesgo para quienes padecen alergias alimentarias. En consecuencia, las describió como un impacto no solo físico, sino también emocional y social, caracterizado por ansiedad, incertidumbre y limitaciones en la plena integración a la vida comunitaria.

Subrayó que las alergias alimentarias severas pueden constituir una discapacidad bajo la *Americans with Disabilities Act* (ADA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, en la medida en que pueden limitar funciones vitales como comer o respirar. Mencionó que, aunque dichas protecciones federales existen, no cubren adecuadamente múltiples escenarios cotidianos donde ocurren incidentes de riesgo, tales como restaurantes, espacios recreativos, actividades escolares y entornos turísticos.

Benitez Ripoll enfatizó que la medida no impone cargas irrazonables ni crea privilegios especiales, sino que establece condiciones mínimas de igualdad y seguridad. En ese sentido, propuso la adopción de protocolos básicos para el manejo de alérgenos, acceso a información clara y mecanismos de respuesta ante emergencias. Además, destacó que otras jurisdicciones han implementado legislación similar con resultados positivos, lo que demuestra la viabilidad y pertinencia del modelo propuesto.

Acentuó que, a diferencia de otras discapacidades visibles, las alergias alimentarias no presentan signos externos evidentes; sin embargo, un error mínimo o una contaminación cruzada puede tener consecuencias fatales en cuestión de minutos. Resaltó que, esta

invisibilidad genera con frecuencia incredulidad, minimización del riesgo y falta de responsabilidad por parte de establecimientos comerciales, lo que agrava la vulnerabilidad de las personas afectadas.

Además, Benítez Ripoll relató experiencias concretas de exclusión y negligencia, particularmente en restaurantes y espacios privados donde no se toman en serio las advertencias sobre alérgenos. Tales situaciones no solo representan un riesgo físico, sino que también generan exclusión social y costos económicos adicionales para las familias. En consecuencia, coligió que la medida legislativa se presenta como un instrumento para promover mayor equidad y consideración hacia estas realidades.



Aunque el joven reconoció que el Proyecto del Senado 780 no resolverá todos los retos asociados a las alergias alimentarias severas, sostuvo que la medida constituye un paso fundamental para afirmar una política pública centrada en la vida, la seguridad y la inclusión. En síntesis, Alejandro Benítez Ripoll concluyó que la medida combina una base jurídica con una experiencia humana concreta, presentando la legislación como una oportunidad para prevenir tragedias, fortalecer la empatía social y garantizar que las personas con alergias alimentarias puedan desenvolverse con dignidad y seguridad en todos los espacios de la vida cotidiana.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 780 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

El análisis ponderado de los memoriales sometidos ante esta Honorable Comisión permite concluir, que existe consenso amplio en torno a la realidad médica y social que enfrentan las personas con alergias alimentarias severas en Puerto Rico. Diversas agencias gubernamentales, entidades académicas y organizaciones consultadas coincidieron en reconocer que dichas alergias constituyen una condición de salud pública seria, potencialmente mortal y con implicaciones funcionales que pueden limitar sustancialmente actividades esenciales de la vida, tales como comer y respirar.

Asimismo, surge del expediente legislativo que, aunque existen marcos federales como la *Americans with Disabilities Act* (ADA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, estos no establecen protocolos específicos ni uniformes para escenarios cotidianos tales como restaurantes, establecimientos comerciales, actividades recreativas, instituciones educativas y espacios turísticos. En consecuencia, se identifica un vacío normativo en el ordenamiento local que dificulta la estandarización de prácticas preventivas y de respuesta inmediata.



Por otra parte, esta Comisión examinó cuidadosamente los planteamientos formulados por aquellas entidades que expresaron reservas respecto a la medida, particularmente en lo relativo a la duplicidad normativa, el impacto fiscal, la carga administrativa al sector privado y la delimitación de competencias regulatorias. Tales preocupaciones, aunque legítimas, no constituyen un impedimento insalvable para la aprobación de la medida, sino que resaltan la necesidad de perfeccionar su redacción mediante enmiendas que delimiten con claridad la autoridad primaria del Departamento de Salud en la reglamentación técnica, establezcan mecanismos de implantación escalonada y definan parámetros razonables de fiscalización y cumplimiento.

De igual manera, la Comisión reconoce que la implementación de protocolos de rotulación, capacitación y disponibilidad de epinefrina requiere una evaluación presupuestaria responsable. No obstante, el interés apremiante del Estado en proteger la vida y la salud de una población vulnerable justifica la adopción de un marco normativo que provea uniformidad, previsibilidad y herramientas efectivas de prevención.

En tercer lugar, esta Comisión enfatiza que la política pública propuesta no crea privilegios, sino que materializa el principio constitucional de igualdad y la obligación estatal de proteger la vida y la dignidad humana. La evidencia médica demuestra que una reacción anafiláctica puede desarrollarse en cuestión de minutos, y que la ausencia de protocolos claros puede resultar fatal. En ese contexto, la prevención constituye una manifestación concreta del deber indelegable del Estado de velar por la salud pública.

Asimismo, la Comisión reconoce que la adopción de esta política pública fortalecerá el posicionamiento de Puerto Rico como un destino seguro e inclusivo, promoviendo la confianza del consumidor y reduciendo riesgos reputacionales para la industria turística y comercial.

Por todo lo cual, esta Comisión determina que: (1) existe un interés público apremiante en establecer un marco normativo local específico sobre alergias alimentarias severas; (2) los marcos federales existentes no resultan suficientes para atender integralmente los escenarios contemplados; (3) las preocupaciones fiscales y administrativas pueden atenderse mediante enmiendas estructurales sin sacrificar el propósito esencial del proyecto; y (4) la protección de personas con alergias alimentarias severas constituye una manifestación de política pública inclusiva y preventiva en materia de salud pública.

En virtud de lo anterior, esta Comisión realizó las siguientes enmiendas a la medida con la finalidad de atender aquellas preocupaciones presentadas por las agencias y entidades consultadas:

- 
- Se fundamentó en la Exposición de Motivos los Estados que han adoptado legislación que incluye la rotulación sobre alergias alimentarias y personal capacitado en los restaurantes, así como guías estatales para el manejo de alergias alimentarias en las escuelas.
 - Se descartó de las obligaciones a restaurantes y establecimientos de alimentos el deber de:
 - incluir advertencias claras en los menús que fomenten la comunicación entre clientes y personal sobre la presencia de alergias;
 - asegurar que, al menos, un miembro del personal por turno, haya recibido capacitación certificada sobre el manejo de alergias alimentarias; e
 - incluir en el menú o mediante señalización visible, los cambios en las recetas que puedan introducir nuevos alérgenos.
 - Se excluyó a las instituciones post secundarias (universidades, colegios técnicos y vocacionales) de las regulaciones.
 - Se eliminó el deber de las escuelas de mantener una cantidad razonable de epinefrina autoinyectable en lugares accesibles, destinada al manejo inmediato de reacciones alérgicas que ocurran en las instalaciones, asegurando que se encuentre dentro de su fecha de vencimiento y sea almacenada de manera segura conforme a las recomendaciones del fabricante.
 - Se descartó la obligación de los centros recreativos, deportivos, culturales, campamentos y aeropuertos con oferta de alimentos de establecer áreas libres de alérgenos en actividades con poblaciones vulnerables.
 - Referente a las campañas de educación y concienciación pública, se excluyó la obligación de implementar programas de formación comunitaria para padres, cuidadores y trabajadores del sector alimentario.

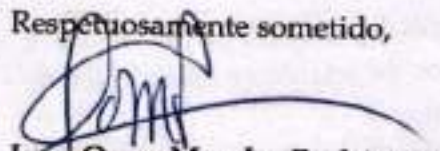
- Se incluyeron multas por la cantidad de \$200.00 dólares por incumplimiento de las disposiciones de la Ley.
- Se estableció que los ingresos por recaudos de multas se depositarán la cuenta creada en virtud de esta Ley.
- Referente al sistema de reporte de incidentes, se clarificó que, en el caso de que la persona que sufra la emergencia relacionada a alergias alimentarias sea menor de edad, se debe salvaguardar las garantías de confidencialidad que brindan Ley HIPPA y las disposiciones aplicables.
- Se eliminó la obligación expresa de que los hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados deban priorizar la atención inmediata de personas que presenten síntomas de anafilaxia o reacciones alérgicas graves, siguiendo los protocolos médicos establecidos y las guías clínicas actualizadas.
- Se especificó la obligación del Departamento de Salud de coordinar la adopción de directrices específicas para fortalecer la respuesta efectiva a estas emergencias de síntomas de anafilaxia o reacciones alérgicas graves.
- Se incluyó un Artículo sobre consignación presupuestaria atendiendo las preocupaciones de posible impacto fiscal.

Finalmente, esta Comisión concluye que el Proyecto del Senado 780 representa una respuesta legislativa proporcional, necesaria y jurídicamente fundamentada ante una realidad médica que incide directamente en la vida, la seguridad y la inclusión de miles de puertorriqueños, reafirmando el compromiso del Estado con la dignidad humana, la igualdad de acceso y la protección de poblaciones vulnerables.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe, **RECOMENDANDO LA APROBACIÓN del Proyecto del Senado 780** con las enmiendas contenidas en el Entrillado Electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Juan Oscar Morales Rodríguez
Presidente
Comisión de Salud

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

2^{da}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 780

15 de octubre de 2025

Presentado por el señor Rivera Schatz (Por Petición)

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para crear la "Ley para la Protección de Personas con Alergias Alimentarias en Puerto Rico", también conocida como "Ley Alejandro Benítez Ripoll"; declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre esta materia; imponer obligaciones a establecimientos de alimentos, instituciones educativas públicas y privadas y ~~entidades postsecundarias~~; establecer disposiciones sobre acceso con alimentos seguros; autorizar reglamentación; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las alergias alimentarias son una condición médica seria que impacta significativamente la vida de miles de niños, jóvenes y adultos. Para quienes viven con alergias severas, la exposición a ciertos alimentos puede provocar reacciones que van desde síntomas leves hasta anafilaxia, una emergencia médica potencialmente mortal. Esta realidad genera un riesgo constante y limita la participación plena y segura de estas personas en espacios escolares, laborales, recreativos, sociales y comerciales.

A diferencia de otras condiciones de salud, las alergias alimentarias no son visibles. Esta invisibilidad puede llevar a actitudes de descuido, incredulidad o falta de preparación en muchos entornos, tanto públicos como privados. Para quienes viven con esta condición, cada actividad cotidiana, como asistir a clases, participar en una

celebración o comer en un restaurante, puede convertirse en un momento de inseguridad, ansiedad o exclusión. Comer fuera de casa, por ejemplo, representa una de las experiencias más limitantes, debido a la falta de protocolos claros, personal capacitado y sensibilidad hacia las instrucciones específicas que requieren estas condiciones. Los errores, aunque prevenibles, se repiten con frecuencia, y muchas veces no hay una verdadera asunción de responsabilidad. Con las herramientas adecuadas y la orientación correcta, muchas de estas situaciones podrían prevenirse. La implementación de protocolos claros representa una oportunidad real de reducir riesgos y mejorar significativamente la calidad de vida de esta población.



A pesar de lo prevenibles que pueden ser muchas de estas situaciones, no existe un marco legal local que exija estas prácticas. A pesar de los avances en el conocimiento médico y de las protecciones que ofrecen leyes federales como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Puerto Rico no cuenta con un marco legal local y específico que atienda de manera integral la realidad de las personas con alergias alimentarias severas. El ADA reconoce que estas alergias pueden considerarse una discapacidad cuando limitan funciones vitales como comer, respirar o el funcionamiento del sistema inmunológico. Por su parte, la Sección 504 prohíbe la discriminación por razón de discapacidad en programas y actividades que reciben fondos federales, incluyendo instituciones educativas, hospitales y agencias gubernamentales. Sin embargo, estas leyes, aunque importantes, no cubren todos los aspectos prácticos ni establecen medidas concretas para entornos como restaurantes, actividades recreativas o espacios comerciales.

Actualmente, no existe uniformidad en la forma en que escuelas, restaurantes y otros espacios manejan las alergias alimentarias, lo que provoca incertidumbre, frustración y un alto nivel de riesgo para las personas afectadas. Por esta razón, Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones en Estados Unidos, necesita adoptar su propia política pública para atender esta condición de forma amplia, actualizada y adaptada a

su contexto. En ese ámbito, estados como Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, entre otros, han adoptado legislación que incluye la rotulación sobre alergias alimentarias y personal capacitado en los restaurantes. Por otro lado, estados como Arizona, Connecticut, Mississippi, Texas y Rhode Island, entre muchos otros, requieren guías estatales para manejo de alergias alimentarias en las escuelas. Esta Ley responde precisamente a esa necesidad y posiciona a Puerto Rico entre las jurisdicciones que han dado pasos concretos para proteger a las personas con alergias alimentarias mediante legislación específica y acción gubernamental coordinada.



Además, atiende situaciones como desastres naturales que exponen a esta población a riesgos aún mayores, al no existir protocolos de emergencia que garanticen su protección alimentaria en refugios u operaciones de ayuda humanitaria. Asimismo, se fortalece el posicionamiento de Puerto Rico como un destino turístico accesible y seguro para visitantes de los Estados Unidos e internacionales que viven con alergias alimentarias, promoviendo entornos de hospitalidad más responsables y preparados.

Esta Ley tiene como propósito establecer una política pública afirmativa que proteja a las personas con alergias alimentarias severas, promueva su inclusión en todos los espacios y prevenga situaciones de emergencia mediante medidas educativas, preventivas y de respuesta inmediata. Se reconocen derechos fundamentales como el acceso a información clara, a protocolos de emergencia, a alimentos seguros, y a la participación plena sin barreras ni discriminación. Se establece, además, obligaciones concretas para escuelas, restaurantes, agencias gubernamentales y establecimientos comerciales en Puerto Rico.

Esta legislación nace como iniciativa de Alejandro Benítez Ripoll, un joven puertorriqueño que vive con alergias alimentarias severas y que, junto a su familia, ha impulsado este esfuerzo tras haber experimentado en múltiples ocasiones la falta de sensibilidad, preparación y responsabilidad en torno a su condición médica. Su testimonio refleja el impacto real que estas barreras imponen sobre la calidad de vida de

quienes viven con esta condición, y representa un llamado urgente a crear una sociedad más justa, consciente y preparada.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título.

Esta Ley se conocerá como la "Ley para la Protección de Personas con Alergias Alimentarias en Puerto Rico", también conocida como "Ley Alejandro Benítez Ripoll".

Artículo 2.- Declaración de Política Pública.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que las alergias alimentarias severas constituyen una condición de salud pública que puede poner en riesgo la vida de niños, jóvenes y adultos. Es deber del Gobierno proteger a estas personas mediante medidas preventivas, educativas y de respuesta rápida ante emergencias.

Se establece una política pública clara y afirmativa para promover la inclusión, la seguridad y la igualdad de condiciones para todas las personas con alergias alimentarias, mediante la creación de entornos informados, preparados y comprometidos con su bienestar.

Artículo 3.- Definiciones.

Las siguientes palabras o términos tendrán los significados que a continuación se expresan:

(a) Alérgenos Alimentarios Principales: alimentos identificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que pueden provocar reacciones alérgicas en el ser humano. Ellos son: leche,

1 huevos, pescado, mariscos crustáceos, frutos secos, maní, trigo, soya, y
2 sésamo.

3 (b) Alergias alimentarias: reacción adversa inmunológica a ciertas proteínas en
4 los alimentos, puede causar síntomas variados, desde leves hasta severos.

5 (c) Anafilaxia: reacción alérgica grave, potencialmente mortal, que involucra
6 problemas respiratorios.

7 (d) Epinefrina autoinyectable: inyección de epinefrina que es utilizada como un
8 medicamento de emergencia para tratar reacciones alérgicas potencialmente
9 severas (anafilácticas).

10 (e) Protocolo de manejo de alergias: Conjunto de guías escritas que establecen la
11 prevención, identificación y respuesta ante reacciones alérgicas.

12 (f) Establecimiento de alimentos: Cualquier lugar que prepare, manipule, sirva o
13 venda productos comestibles.

14 Artículo 4.- Obligaciones de Restaurantes y Establecimientos de Alimentos.

15 Los establecimientos deberán:

16 (a) Colocar un cartel informativo en el área de cocina y en zonas visibles al
17 público que describa los alérgenos más comunes y la importancia de notificar
18 alergias al personal.

19 ~~(b) Incluir advertencias claras en los menús que fomenten la comunicación entre~~
20 ~~clientes y personal sobre la presencia de alergias.~~

21 ~~(c) Asegurar que al menos un miembro del personal por turno haya recibido~~
22 ~~capacitación certificada sobre el manejo de alergias alimentarias.~~

1 (d) ~~(b)~~ Establecer protocolos internos para prevenir la contaminación cruzada
2 de alimentos con alérgenos, y asegurar que el personal esté capacitado,
3 conozca y pueda aplicar dichas medidas preventivas de manera efectiva.

4 (e) ~~(c)~~ Indicar de forma clara en los menús la presencia de alérgenos comunes
5 en cada platillo, utilizando símbolos, códigos o leyendas uniformes conforme
6 a guías del Departamento de Salud.

7 ~~(f)~~ ~~(d)~~ Informar a los consumidores sobre cualquier cambio en las recetas que
8 pueda introducir nuevos alérgenos, ~~mediante avisos en el menú o~~
9 ~~señalización visible en el punto de venta.~~

 10 ~~(g)~~ ~~(e)~~ Mantener protocolos de limpieza estrictos para superficies, utensilios y
11 equipos, así como áreas designadas de preparación de alimentos libres de
12 alérgenos cuando se atiendan pedidos de personas con alergias alimentarias
13 conocidas.

14 ~~(h)~~ ~~(f)~~ El Departamento de Salud podrá establecer exenciones o ajustes
15 regulatorios para microempresas o negocios de alimentos que operen con
16 recursos limitados, siempre que dichas exenciones o ajustes no comprometan
17 la salud, seguridad y derechos de las personas con alergias alimentarias.

18 Artículo 5.- Requisitos para Escuelas públicas, y privadas ~~y postsecundarias~~.

19 Las instituciones educativas, incluyendo escuelas públicas, y privadas y
20 ~~entidades de educación postsecundaria tales como universidades, colegios técnicos y~~
21 ~~vocacionales,~~ deberán:

1 (a) Contar con un protocolo escrito aprobado por el Departamento de
2 Educación y el Departamento de Salud que detalle acciones preventivas y de
3 emergencia ante alergias alimentarias.

4 ~~(b) Mantener una cantidad razonable de epinefrina autoinyectable en lugares~~
5 ~~accesibles, destinada al manejo inmediato de reacciones alérgicas que ocurran~~
6 ~~en las instalaciones, asegurando que se encuentre dentro de su fecha de~~
7 ~~vencimiento y sea almacenada de manera segura conforme a las~~
8 ~~recomendaciones del fabricante.~~

9 (e) (b) Ofrecer educación anual al personal sobre alergias alimentarias,
10 incluyendo primeros auxilios, uso de epinefrina y promoción de entornos
11 inclusivos.

12 (d) (c) Garantizar el derecho de los estudiantes con prescripción médica a
13 tener acceso inmediato a su epinefrina autoinyectable en caso de una reacción
14 alérgica. Para aquellos estudiantes cuya edad, madurez y evaluación médica
15 lo permitan, se deberá autorizar que porten y se autoadministren el
16 medicamento sin necesidad de aprobación previa del personal escolar en
17 situaciones de emergencia. Las instituciones no podrán limitar su posesión ni
18 demorar su uso cuando esté médicamente indicado.

19 (e) (d) Informar a estudiantes, padres, madres o encargados, según aplique,
20 sobre la política institucional de alergias.

21 (f) (e) Para estudiantes diagnosticados con alergias alimentarias severas, las
22 escuelas deberán adoptar el plan individualizado de manejo recomendado

1 por el médico del estudiante en coordinación con padres o encargados, el
2 estudiante y personal de salud autorizado, incluyendo:

- 3 i. Medidas preventivas personalizadas.
4 ii. Protocolo específico de emergencia.
5 iii. Revisión y actualización anual del plan.
6 iv. Determinación clara sobre si el estudiante está autorizado a portar y
7 autoadministrarse epinefrina, tomando en cuenta su edad, capacidad y
8 evaluación médica.
9 v. Este plan deberá ser conocido por el personal pertinente de la
10 institución, en cumplimiento con las normas de confidencialidad
11 aplicables.

12 Artículo 6 - Otros Entornos Públicos y Comerciales.

13 Los centros recreativos, deportivos, culturales, campamentos y aeropuertos con
14 oferta de alimentos deberán:

15 (a) Implementar medidas similares a las de los restaurantes para prevención,
16 educación y respuesta ante alergias alimentarias.

17 ~~(b) Establecer áreas libres de alérgenos en actividades con poblaciones~~
18 ~~vulnerables.~~

19 (e) (b) Permitir el ingreso y uso de epinefrina por personas autorizadas.

20 Artículo 7. - Campañas de Educación y Concienciación Pública.

21 El Departamento de Salud, en conjunto con otras agencias pertinentes, diseñará e
22 implementará:

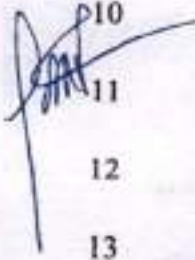
1 (a) Campañas educativas sobre alergias alimentarias en los medios de
2 comunicación.

3 ~~(b) Programas de formación comunitaria para padres, cuidadores y trabajadores~~
4 ~~del sector alimentario.~~

5 (e) ~~(b)~~ Recursos digitales y materiales impresos de acceso gratuito.

6 Artículo 8.- Reglamentación, Coordinación Interagencial y Penalidades.

7 (a) El Departamento de Salud y el Departamento de Asuntos del Consumidor
8 (DACO) establecerán los reglamentos necesarios para la ejecución de esta Ley en
9 un plazo no mayor de ciento veinte (120) días a partir de su aprobación.



10 (b) El Departamento de Salud coordinará con el Departamento de Educación, el
11 Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Compañía de Turismo de
12 Puerto Rico y cualquier otra agencia pertinente, el desarrollo de campañas
13 educativas, materiales de orientación, guías técnicas y procesos de fiscalización
14 relacionados con esta Ley. Las agencias deberán colaborar activamente en la
15 ejecución de la política pública aquí establecida y en el desarrollo de estrategias
16 de implementación conjunta.

17 (c) Los reglamentos y guías técnicas podrán incluir estándares mínimos para
18 inspección, supervisión o auditoría, según el alcance de cada agencia y conforme
19 a sus facultades legales.

20 (d) El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley podrá conllevar sanciones
21 administrativas, incluyendo amonestaciones, multas de \$200 ~~e y~~ la suspensión de
22 licencias, según corresponda y conforme a los reglamentos adoptados por las

1 agencias competentes, según lo dispuesto en la "Ley de Procedimiento Administrativo
2 Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". Los ingresos por recaudos de multas se
3 depositarán la cuenta creada en virtud de esta Ley. La gravedad de la falta y la
4 reincidencia serán consideradas al determinar las penalidades aplicables.

5 (e) El Departamento de Salud y el Departamento de Asuntos del Consumidor
6 (DACO) podrán establecer opciones graduales de cumplimiento para
7 microempresas y pequeños negocios en sus reglamentos. Estas opciones podrán
8 incluir requisitos simplificados o plazos de implementación extendidos, siempre
9 y cuando no se comprometa la salud y seguridad de las personas con alergias
10 alimentarias ni se limiten los derechos reconocidos en esta Ley.

11 Artículo 9.- Derecho a Acceder con Alimentos Seguros.

12 Toda persona con alergias alimentarias tendrá derecho a ingresar con alimentos
13 personales seguros a lugares donde ~~normalmente~~ se restrinja el acceso a comida
14 externa. Esta disposición aplicará a espacios públicos y privados tales como teatros,
15 estadios, salas de cine, coliseos, centros de convenciones, hoteles, parques de
16 diversiones, excursiones organizadas, y otros lugares recreativos, culturales, deportivos,
17 educativos o turísticos.

18 Ningún comercio o entidad podrá penalizar, discriminar o impedir el acceso de
19 una persona amparada bajo esta Ley por portar alimentos seguros.

20 Artículo 10.- Programa de Certificación Voluntaria.

21 Se autoriza al Departamento de Salud a desarrollar y promover un programa
22 voluntario de certificación para establecimientos de alimentos denominado

1 "Restaurante Amigable con Alergias". La certificación podrá ser otorgada a
2 establecimientos que, además de cumplir con las disposiciones ~~obligatorias~~ de esta Ley:

3 (a) Capaciten a ~~la totalidad de~~ su personal, tanto de cocina como de servicio, en
4 prevención y manejo de alergias alimentarias.

5 (b) Implementen y mantengan protocolos documentados y verificables para
6 evitar la contaminación cruzada, incluyendo prácticas de almacenamiento,
7 preparación y servicio.

8 (c) Ofrezcan menús con información detallada sobre alérgenos, así como una o
9 más opciones seguras diseñadas específicamente para personas con alergias
10 alimentarias.

11 (d) Participen en iniciativas educativas o de concienciación pública promovidas
12 por el Departamento de Salud.

13 El Departamento de Salud podrá publicar un listado oficial de establecimientos
14 certificados y promover su reconocimiento público como modelo de buenas prácticas.

15 El programa de certificación deberá revisarse y actualizarse periódicamente conforme a
16 las mejores prácticas médicas, reglamentación vigente o nuevas recomendaciones de
17 agencias especializadas en salud y nutrición.

18 Artículo 11.- Sistema de Reporte de Incidentes.

19 Todo establecimiento de alimentos y toda institución educativa deberá
20 documentar cualquier incidente relacionado con reacciones alérgicas que ocurra en sus
21 instalaciones. Esta información deberá ser reportada al Departamento de Salud dentro
22 de un plazo no mayor de cinco (5) días laborables, con el fin de contribuir a la

1 recopilación de datos relevantes sobre la implementación de esta Ley. En el caso de que la
2 persona que sufra la emergencia relacionada a alergias alimentarias sea menor de edad, se debe
3 salvaguardar las garantías de confidencialidad que brindan la "Ley de Portabilidad y
4 Responsabilidad del Seguro de Salud" (Ley HIPPA, por sus siglas en inglés) y las disposiciones
5 aplicables.

6 El Departamento de Salud creará un portal digital oficial donde se pueda recibir
7 esta información de forma segura, y se asegurará de que el sistema sea accesible,
8 estandarizado y protegido conforme a leyes de confidencialidad aplicables.

9 Asimismo, publicará un informe anual con datos agregados sobre estos
10 incidentes, el cual estará disponible al público de manera electrónica a través de su sitio
11 web oficial. Esta publicación servirá de herramienta para orientar el desarrollo de
12 políticas públicas, campañas educativas y procesos de mejora continua.

13 Artículo 12.- Atención de Emergencias en Hospitales y Centros de Salud.

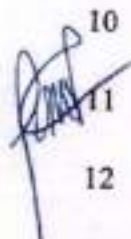
14 ~~Los hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados deberán priorizar~~
15 ~~la atención inmediata de personas que presenten síntomas de anafilaxia o reacciones~~
16 ~~alérgicas graves, siguiendo los protocolos médicos establecidos y las guías clínicas~~
17 ~~actualizadas.~~

18 El Departamento de Salud coordinará la adopción de directrices específicas para
19 fortalecer la respuesta efectiva a estas emergencias de síntomas de anafilaxia o reacciones
20 alérgicas graves, incluyendo la capacitación de personal y la disponibilidad de equipos y
21 medicamentos necesarios.

22 Artículo 13.- Registro Voluntario para Fines Estadísticos y de Política Pública.

1 El Departamento de Salud deberá crear y mantener un registro voluntario y
2 confidencial de personas diagnosticadas con alergias alimentarias severas, con el único
3 fin de recopilar información estadística que oriente la formulación de política pública,
4 planificación de servicios, campañas educativas y evaluación del cumplimiento de esta
5 Ley.

6 El registro podrá utilizarse también para promover mejores servicios y atención
7 diferenciada a esta población, incluyendo la distribución de material educativo, la
8 coordinación de iniciativas comunitarias y la identificación de necesidades en
9 situaciones de emergencia, siempre y cuando la participación sea completamente
10 voluntaria y no condicione el acceso a los derechos aquí garantizados.



11 El registro no podrá ser utilizado para fines de vigilancia individual, ni como
12 requisito para el ejercicio de derechos garantizados por esta Ley. Su diseño deberá
13 cumplir con toda legislación aplicable sobre privacidad y confidencialidad de
14 información médica y personal.

15 El Departamento de Salud deberá establecer mecanismos para el consentimiento
16 informado de las personas interesadas o de sus padres o encargados legales, según
17 aplique.

18 **Artículo 14.- Preparación y Respuesta en Situaciones de Emergencia.**

19 El Departamento de Salud, en coordinación con el Negociado para el Manejo de
20 Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y otras agencias pertinentes,
21 deberá incorporar en sus planes de preparación y respuesta ante emergencias o

1 desastres naturales medidas específicas dirigidas a proteger la salud y seguridad de
2 personas con alergias alimentarias severas.

3 Estas medidas deberán incluir, entre otras:

4 (a) La consideración de necesidades dietarias especiales en la planificación de
5 alimentos para refugios, centros de distribución y otros espacios de emergencia.

6 (b) La inclusión de personas con alergias alimentarias en los protocolos de
7 identificación y atención prioritaria en situaciones de emergencia.

8 (c) La capacitación del personal encargado de refugios y centros de atención sobre el
9 manejo seguro de alimentos y los riesgos asociados a la exposición accidental a
10 alérgenos.



11 (d) Permitir el ingreso y uso de alimentos personales seguros en refugios u otros
12 espacios temporeros cuando sea necesario para proteger la salud de personas con
13 alergias alimentarias.

14 El cumplimiento de esta disposición deberá coordinarse, cuando sea posible, con el
15 registro voluntario aquí establecido, respetando siempre la confidencialidad de los
16 datos personales.

17 Artículo 15.- Guías Técnicas.

18 El Departamento de Salud desarrollará guías técnicas para apoyar la
19 implementación de esta Ley en instituciones educativas, establecimientos de alimentos
20 y otros entornos relevantes.

Estas guías deberán estar disponibles públicamente y mantenerse actualizadas en coordinación con las agencias pertinentes, conforme a los objetivos de esta Ley y las mejores prácticas de atención en el manejo de alergias alimentarias.

Las guías técnicas incluirán, entre otros aspectos:

(a) Recomendaciones sobre prácticas de atención que fortalezcan la seguridad y confianza de las personas con alergias alimentarias, como:

(i) Preguntar proactivamente si algún comensal tiene alergias.

(ii) Establecer una coordinación efectiva entre cocina y personal de servicio.

(iii) Identificar visualmente los platos preparados para personas con alergias.

(iv) Asegurar que la entrega del alimento se realice de manera clara, segura y conforme a las instrucciones recibidas.

(b) Recomendaciones para la capacitación del personal en el uso de epinefrina en situaciones de emergencia, cuando sea razonable según sus funciones y nivel de responsabilidad.

(c) Recomendaciones específicas para ~~instituciones postsecundarias~~, centros turísticos y actividades comunitarias, de manera que puedan alinearse con los principios y objetivos de esta Ley.

(d) Mecanismo que permita corroborar que las excepciones establecidas en esta Ley, responden a una necesidad médica legítima.

Artículo 16.- Consignación Presupuestaria.

Los ingresos devengados como resultado de las multas recaudadas por el incumplimiento de esta Ley, se consignarán en la cuenta establecida para el Departamento de Salud en el

1 Departamento de Hacienda para la operación del portal del sistema de reporte de incidentes; para
2 el registro voluntario de personas diagnosticadas con alergias alimentarias severas; para
3 campañas educativas sobre alergias alimentarias; para el programa de certificación voluntaria; o
4 para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. El Departamento de Salud tendrá la
5 responsabilidad de entregar un Informe Anual sobre el uso de estos fondos el cual será sometido
6 ante la Secretaría de cada uno de los cuerpos legislativos en antes de cada día treinta (30) de
7 junio de cada año mientras durante la vigencia de esta Ley.

8 Artículo ~~16~~17.- Implementación por Fases.

9 El Departamento de Salud, en coordinación con las agencias pertinentes, establecerá
10 un plan de implementación por fases para asegurar la efectiva adopción de esta Ley,
11 priorizando espacios escolares y establecimientos de alimentos con mayor riesgo para
12 personas con alergias.

13 Artículo ~~17~~18.- Cláusula de Separabilidad.

14 Si cualquier disposición de esta Ley fuere declarada nula o inconstitucional, tal
15 declaración no afectará las demás disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor
16 y efecto.

17 Artículo ~~18~~19. - Interpretación y Alcance.

18 Ninguna disposición de esta Ley deberá interpretarse como una limitación a los
19 derechos que las personas con alergias alimentarias puedan tener conforme a otras
20 leyes estatales o federales vigentes. Esta deberá interpretarse de forma liberal y a favor
21 de la protección e inclusión de esta población.

22 Artículo ~~19~~20.- Vigencia.

- 1 Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación.

A handwritten signature in blue ink, located on the left side of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly "P. M. L." or similar, followed by a long horizontal stroke.